

TEMA 5.6 • OFTALMOLOGÍA

ojo rojo profundo

PERFIL EUNACOM 6.02.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología Inflamatoria de los Párpados y Vía Lagrimal

- En el contexto del ojo rojo periférico y patología de anexos oculares, existen cuatro entidades principales que se deben reconocer y tratar desde el nivel primario:
- Blefaritis
- Chalazión
- Orzuelo
- Dacriocistitis Aguda

1. Blefaritis

Es la inflamación crónica de los párpados, específicamente del borde libre palpebral.

• **Clínica:**

Diagnóstico: Absolutamente clínico. (Blefaritis anterior compromete visiblemente las pestañas, blefaritis posterior compromete las glándulas de Meibomio más adentro).

Tratamiento:

- Aseo ocular frecuente:** es la piedra angular del tratamiento.
- Tratamiento de la causa subyacente (ej: manejo de la rosácea, lágrimas artificiales si hay ojo seco).

2. Chalazión vs. Orzuelo

Muchas veces son clínica y visualmente indistinguibles en la etapa inflamatoria, pero hay distinciones fisiopatológicas y de curso temporal que inciden en el manejo y la derivación.

TABLA 5.6.1: CARACTERÍSTICA VS ORZUELO		
CARACTERÍSTICA	ORZUELO	CHALAZIÓN
Fisiopatología	Obstrucción e infección aguda del folículo piloso de la pestaña.	Obstrucción de la glándula de Meibomio .
Localización típica	En el borde mismo del párpado (ligado a la pestaña).	Más alejado del borde del párpado (más arriba/adentro).
Inicio de síntomas	Súbito (cuestión de horas, amanece con dolor o hinchado).	Más insidioso, demora algunos días en engrosarse.
Duración esperada	1 a 2 semanas .	Crónico, puede durar 1 a 2 meses .

- **Clínica en ambos:** Aumento de volumen en el párpado con eritema y dolor. - **Tratamiento general para ambos:** - Medida principal: **Masaje en la zona con calor húmedo** de forma localizada (ej: compresa o toalla tibia), de modo de fundir la secreción retenida. - Observación clínica. - **Derivación:** Se derivan al oftalmólogo cuando el cuadro **se absceda** (requiriendo eventualmente un drenaje quirúrgico con incisión) o cuando no responden al tratamiento luego del plazo esperado (1-2 semanas para orzuelo, 1-2 meses para chalazión, para descartar tumores).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En un orzuelo intensamente abscedado y eritematoso, el cuadro se puede complicar con una incipiente **Celulitis Preseptal**. Esto cambia la categorización del cuadro obligando a prescribir antibióticos sistémicos inmediatamente.

3. Dacriocistitis Aguda

Es la inflamación e infección del **saco lagrimal**. Constituye casi invariablemente la complicación aguda de una **Obstrucción de la Vía Lagrimal** preexistente .

• **Clínica:**

- Aumento de volumen delimitado a la zona del saco lagrimal (región **medial o infero-medial** del canto interno del ojo).
- Severo eritema y dolor.
- Epífora persistente (la vía de drenaje de lágrimas está ocluida).
- Signo Patognomónico: Al comprimir levemente el saco inflamado puede refluir **pus por el punto lagrimal**.
- **Evolución y Complicaciones:** Aunque puede autolimitarse, tiene un real riesgo de avanzar y propagarse a algo más grave:
 - **Celulitis Preseptal** o, mucho más preocupante, **Celulitis Orbitaria**.
 - Absceso francos o incluso Meningitis bacteriana aguda por continuidad venosa en casos pediátricos negligidos.
- **Tratamiento Inmediato:** Su abordaje **es siempre sistémico (vía oral)**, dado que los antibióticos tópicos no logran perfundir y lavar el sistema de drenaje cerrado e inflamado.
 - Fármaco de elección empírico: **Amoxicilina/Ácido Clavulánico** (cubre eficientemente al *Staphylococcus aureus* metilino sensible).
 - Fármaco en alérgicos: **Clindamicina**.

- Eritema en el borde de los párpados (borde externo o interno).
- Presencia de **descamación** ("caspita") en la piel del párpado y la base de las pestañas.
- Síntomas asociados: ardor, "ojo rojo" leve, epífora (lagrimeo excesivo).
- **Causas:** Muy variadas (ojo seco, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto).
- **ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN**
La causa más importante que el médico general debe saber identificar es la **Rosácea**. Una blefaritis crónica resistente muchas veces responde a una rosácea ocular concomitante oculta.
-

EUNACOM CRITERIOS

En caso de que un niño sufra dacriocistitis recurrente, debes sospechar firmemente una **obstrucción congénita del conducto nasolagrimal** que requiere eventual cateterización y sondaje.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un soldador de cuarenta años consulta a las dos de la madrugada por dolor ocular intenso bilateral, fotofobia severa y blefarospasmo que comenzó cuatro horas después de su jornada de trabajo. Al examen con fluoresceína se observan múltiples puntitos que captan el colorante en ambas córneas. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para ojo rojo profundo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La queratitis se presenta con dolor, fotofobia, blefarospasmo y enrojecimiento periquerático; la pupila se mantiene normal en patología corneal.
- El diagnóstico de lesiones corneales se confirma con fluoresceína, que tiñe las zonas de pérdida epitelial visibles con luz azul.
- La queratitis herpética produce una úlcera dendrítica o en helecho, prácticamente patognomónica de herpes simple ocular, tratamiento con aciclovir tópico y oral.
- La queratitis actínica se produce por exposición a luz ultravioleta como soldador, el dolor aparece horas después, tratamiento con antiinflamatorios tópicos.
- El parche ocular está contraindicado en usuarios de lentes de contacto por riesgo de infección por *Pseudomonas aeruginosa*.
- En la patología corneal la pupila es normal, lo que permite diferenciarla de la uveítis donde hay miosis y del glaucoma donde hay midriasis fija.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OJO ROJO PROFUNDO)**PREGUNTA 1**

Un soldador de cuarenta años consulta a las dos de la madrugada por dolor ocular intenso bilateral, fotofobia severa y blefarospasmo que comenzó cuatro horas después de su jornada de trabajo. Al examen con fluoresceína se observan múltiples puntitos que captan el colorante en ambas córneas. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Queratitis bacteriana bilateral; tratamiento con antibióticos tópicos
- B)** Queratitis actínica por exposición a ultravioleta; tratamiento con antiinflamatorios tópicos y analgésicos
- C)** Queratitis herpética bilateral; tratamiento con aciclovir tópico y oral
- D)** Conjuntivitis viral bilateral; tratamiento sintomático
- E)** Uveítis anterior bilateral; tratamiento con corticoides tópicos

PREGUNTA 2

Un paciente de treinta y cinco años portador de lentes de contacto consulta por ojo rojo derecho con dolor y fotofobia de veinticuatro horas. Con fluoresceína se observa una úlcera corneal central que capta el colorante, con bordes irregulares. ¿Cuál es la consideración más importante en el manejo de este paciente?

- A)** Indicar parche ocular compresivo para reducir el dolor
- B)** Iniciar aciclovir tópico ante sospecha de herpes simple
- C)** No usar parche ocular y derivar urgente al oftalmólogo para cultivo y antibióticos tópicos específicos
- D)** Iniciar corticoides tópicos para controlar la inflamación
- E)** Observar y controlar en cuarenta y ocho horas sin tratamiento inicial

PREGUNTA 3

Un joven de veintidós años consulta por ojo rojo izquierdo con dolor intenso, fotofobia y blefarospasmo. Al examen con lámpara de hendidura se observa una úlcera corneal con un patrón que recuerda a las ramas de un árbol o a un helecho. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento más adecuado?

- A)** Queratitis bacteriana; tratamiento con ciprofloxacino tópico
- B)** Queratitis herpética; tratamiento con aciclovir tópico y oral
- C)** Queratitis actínica; tratamiento con antiinflamatorios tópicos
- D)** Erosión corneal traumática; tratamiento con parche y antibiótico tópico
- E)** Úlcera de Mooren; tratamiento con corticoides tópicos

RESUMEN: OJO ROJO PROFUNDO

El ojo rojo profundo o periquerático corresponde a patologías que comprometen estructuras más internas del ojo que la conjuntiva. En esta clase se revisan las principales causas de ojo rojo profundo, con énfasis en las queratitis. La queratitis bacteriana se presenta con dolor, fotofobia, blefarospasmo y enrojecimiento periquerático. La córnea puede mostrar una opacidad o úlcera visible. La pupila en cambio está normal, y esto es un punto clave: en la patología corneal la pupila se mantiene normal. El diagnóstico se confirma con fluoresceína, que tiñe las zonas de pérdida del epitelio corneal y se ve verde con luz azul. La queratitis herpética es especialmente importante: produce una úlcera corneal con patrón dendrítico o en helecho, que es prácticamente patognomónica. El tratamiento es aciclovir tópico más aciclovir oral. Otra queratitis que hay que conocer es la actínica, producida por exposición a luz ultravioleta intensa como la luz de soldador. Se presenta con dolor intenso, fotofobia y blefarospasmo varias horas después de la exposición. El tratamiento son antiinflamatorios no esteroideos tópicos y analgésicos. Un punto importante es que el parche ocular está contraindicado en usuarios de lentes de contacto ya que favorece las infecciones por pseudomonas. Las erosiones corneales se diagnostican con fluoresceína y se tratan con antibiótico tópico y eventualmente parche, excepto en portadores de lentes de contacto.